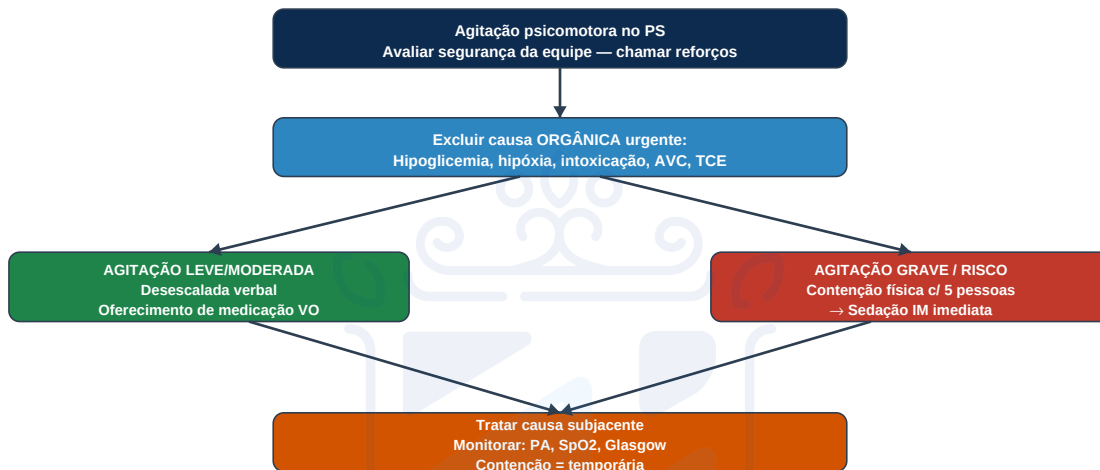


AGITAÇÃO — CAUSA + CONTENÇÃO SEGURA

ABORDAGEM ESCALONADA — AGITAÇÃO

AGITAÇÃO — VERBAL ANTES DO QUÍMICO



CAUSA ORGÂNICA vs PSIQUIÁTRICA

Achado	Sugere Orgânico	Sugere Psiquiátrico
Início	Súbito, sem histórico prévio	Gradual, histórico psiquiátrico
Orientação	Desorientado (delirium)	Orientado (psicose funcional)
Sinais vitais	Alterados (febre, hipóxia, taquicardia)	Geralmente normais
Pupilas	Mióticas (opioides), midriáticas (simpático)	Normais
Consciência	Flutuante (piora à noite — 'sundowning')	Preservada
Idade	Extremos de idade (idoso, criança)	Adulto jovem mais comum

SEDAÇÃO FARMACOLÓGICA — OPÇÕES

Fármaco	Dose IM/IV	Indicação preferencial	Cuidados
Haloperidol	5 mg IM (2,5 mg idoso)	Psicose, delirium	Monitorar QTc; evitar em EPS
Olanzapina	10 mg IM	Psicose, mania	Não combinar com BZD IM (apneia)
Midazolam	5 mg IM / 2 mg IV	Abstinência alcoólica, intoxicação	Depressão respiratória
Lorazepam	2-4 mg IM	Agitação por BZD/álcool	Sedação intensa, monitorar
Droperidol	2,5-5 mg IM	Alternativa ao haloperidol	Monitorar QTc
Combinação	Haloperidol 5mg + Prometazina 50mg IM	Agitação intensa psiquiátrica	Evitar em idoso/DPOC

CONTENÇÃO FÍSICA — REGRAS

COMO FAZER COM SEGURANÇA

- Mínimo 5 pessoas: 1 para cada membro + 1 para a cabeça + 1 líder (coordena, dá medicação)
- Comunicar ao paciente antes: 'vamos te ajudar a se acalmar'
- Decúbito dorsal: NUNCA em decúbito ventral (risco de asfixia posicional — mortalidade)
- Monitorar a cada 15 min: circulação nos membros, respiração, SpO2, nível de consciência
- Contenção é temporária: reavaliação a cada 2h; retirar o mais cedo possível
- Documentar: motivo, hora de início, profissional responsável, monitoramento

AGITAÇÃO POR SUBSTÂNCIAS — CONDUTA ESPECÍFICA

Álcool / Abstinência

- Abstinência: benzodiazepínico (diazepam 10-20mg IV/VO) — escala CIWA
- Intoxicação aguda: reposição volêmica, tiamina, monitorar
- Delirium tremens: BZD altas doses, UTI se convulsão
- NÃO usar haloperidol como primeira escolha na abstinência

Cocaína / Anfetamina

- Simpaticomimético: midriase, taquicardia, HAS, agitação
- Benzodiazepínico IV/IM — não antipsicótico (abaixa limiar convulsivo)
- Monitorar temperatura (hipertermia maligna possível)
- Resfriamento ativo se >39°C; reposição volêmica

CHECKLIST — AGITAÇÃO NO PS

SISTEMATIZAR A ABORDAGEM

- ☐ Segurança: remover objetos perigosos da sala; equipe em número suficiente
- ☐ Causa orgânica: glicemia, SpO2, Glasgow, PA, temperatura, toxicológico
- ☐ Desescalada verbal: tom calmo, linguagem simples, oferecer escolha
- ☐ Sedação VO preferível se aceita: haloperidol 5mg VO ou olanzapina 10mg VO
- ☐ Sedação IM se recusa ou risco imediato: haloperidol 5mg ± prometazina 50mg
- ☐ Contenção física: decúbito dorsal, mínimo 5 pessoas, monitorar, documentar
- ☐ Após estabilização: avaliar psiquiatria, internação voluntária vs involuntária

SM24

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente agitado, desorientado, com febre, taquicardia e SpO2 de 88%. Qual é a conduta PRIORITÁRIA?

- A) Sedação imediata com haloperidol IM
- B) Contenção física e encaminhar à psiquiatria
- C) Investigar causa orgânica (hipóxia, infecção, intoxicação) e tratar causa de base
- D) Administrar diazepam 10 mg IV
- E) Solicitar avaliação psiquiátrica antes de qualquer medida

QUESTÃO 2

CFM / Adaptada

Qual posição é CONTRAINDICADA durante a contenção física de paciente agitado?

- A) Decúbito dorsal com membros fixados
- B) Decúbito lateral de segurança
- C) Decúbito ventral (posição prona)
- D) Semissentado (30°)
- E) Lateral esquerdo

QUESTÃO 3

AMRIGS / Adaptada

Paciente alcoolista, último drinque há 36 horas, agitação, tremor, sudorese e alucinações visuais. Qual tratamento farmacológico é de PRIMEIRA LINHA?

- A) Haloperidol 5 mg IM
- B) Olanzapina 10 mg IM
- C) Diazepam 10-20 mg IV com titulação pela escala CIWA
- D) Clonidina oral
- E) Naloxona 0,4 mg IV

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual combinação intramuscular deve ser EVITADA por risco de apneia?

- A) Haloperidol IM + prometazina IM
- B) Olanzapina IM + benzodiazepínico IM
- C) Droperidol IM + haloperidol IM
- D) Midazolam IM + prometazina IM
- E) Haloperidol IM + haloperidol IV

QUESTÃO 5

UFPR / Adaptada

Em paciente com agitação por intoxicação de cocaína (simpaticomimético), qual é a classe preferida para sedação?

- A) Antipsicótico típico (haloperidol)
- B) Antipsicótico atípico (olanzapina)
- C) Benzodiazepínico (midazolam, diazepam)
- D) Anticonvulsivante (fenitoína)
- E) Betabloqueador isolado

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Febre + desorientação + taquicardia + hipóxia = agitação de causa ORGÂNICA (delirium). Tratar a causa é prioridade. Sedação sem investigar pode mascarar doença grave. Descartar hipóxia, hipoglicemia, infecção, TCE.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Decúbito ventral (prona) durante contenção causa asfixia posicional — compressão torácica, impossibilidade de expiração, mortalidade. Sempre decúbito dorsal. Monitorar 15/15 minutos. Documentar.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Abstinência alcoólica: benzodiazepínico (diazepam, lorazepam) titulado pela escala CIWA-Ar é padrão-ouro. Haloperidol não previne convulsão. Delirium tremens: BZD em altas doses, UTI. Tiamina antes de qualquer glicose.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Olanzapina IM + BZD IM = risco de depressão respiratória/apneia grave — combinação contraindicada. Haloperidol + prometazina (IM) é combinação clássica segura para agitação psicótica intensa.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Cocaína = simpaticomimético. Benzodiazepínico é preferido: abaixa FC, PA, temperatura e agitação de forma segura. Antipsicóticos podem baixar o limiar convulsivo e piorar o quadro em intoxicação por estimulantes.

SM24
Suporte ao Plantão Médico